テスト用架空事例

認定結果(テスト用設定)

要介護度	要介護1
認定日	令和8年11月5日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年10月1日～令和9年3月31日(6か月)(テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年10月 日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	新規申請		
対象者氏名	木村 正一 (きむら しょういち)	性別	男
生年月日	昭和23年(1948年)2月3日	年齢	78歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

利用なし(今回が初めての申請)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	妻(75歳)と二人暮らし。妻は高血圧の通院中だが家事全般をこなしている。長女(48歳)は県内の隣町在住で月2回程度来訪。次男(45歳)は県外在住。
居住環境	持ち家の木造平屋。段差は玄関の上がり框(約20cm)のみ。屋内に手すりはないが、移動に支障はない。
使用している機器等	なし。
生活歴	元町役場職員。定年退職後は自治会長を2期務めた。趣味は囲碁と庭木の手入れ。昨年、物損事故をきっかけに運転免許を自主返納してから外出が減った。
本人・家族の主訴	本人:「物忘れは年相応。まだ大丈夫だから、人の世話にはなりたくない。」 妻:「同じことを何度も聞かれて疲れる。薬を飲んだか本人もわからなくなるので、糖尿病の薬が心配。」 長女:「父が家にこもりがちになったので、人と話せる場所に行ってほしい。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない)　左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	(ない)　肩関節　股関節　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	(つかまらないでできる)　何かにつかまればできる　できない
1-4 起き上がり	(つかまらないでできる)　何かにつかまればできる　できない
1-5 座位保持	(できる)　自分の手で支えればできる　支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	(支えなしでできる)　何か支えがあればできる　できない
1-7 歩行	(つかまらないでできる)　何かにつかまればできる　できない
1-8 立ち上がり	(つかまらないでできる)　何かにつかまればできる　できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる　(何か支えがあればできる)　できない
1-10 洗身	(介助されていない)　一部介助　全介助　行っていない
1-11 つめ切り	(介助されていない)　一部介助　全介助
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない))　約1m離れた視力確認表の図が見える　目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない　見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通)　普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる　ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-2 移動	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-3 えん下	(できる)　見守り等　できない
2-4 食事摂取	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-5 排尿	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-6 排便	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-7 口腔清潔	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-8 洗顔	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-9 整髪	(介助されていない)　一部介助　全介助
2-10 上衣の着脱	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-11 ズボン等の着脱	(介助されていない)　見守り等　一部介助　全介助
2-12 外出頻度	(週1回以上)　月1回以上　月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	(調査対象者が意思を他者に伝達できる)　ときどき伝達できる　ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	できる　(できない)
3-3 生年月日や年齢を言う	(できる)　できない
3-4 短期記憶	できる　(できない)
3-5 自分の名前を言う	(できる)　できない
3-6 今の季節を理解する	(できる)　できない
3-7 場所の理解	(できる)　できない

3-8 徘徊	(ない)　ときどきある　ある
3-9 外出すると戻れない	(ない)　ときどきある　ある
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	ない　(ときどきある)　ある
4-2 作話	(ない)　ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	ない　(ときどきある)　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない)　ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	ない　ときどきある　(ある)
4-6 大声をだす	(ない)　ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	(ない)　ときどきある　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない)　ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない)　ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない)　ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない)　ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	ない　ときどきある　(ある)
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない)　ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない)　ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない)　ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない　(一部介助)　全介助
5-2 金銭の管理	介助されていない　(一部介助)　全介助
5-3 日常の意思決定	できる(特別な場合でもできる)　(特別な場合を除いてできる)　日常的に困難　できない
5-4 集団への不適応	(ない)　ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　(見守り等)　一部介助　全介助
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)　□気管切開の処置　□疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置　□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　(J1)　J2　A1　A2　B1　B2　C1　C2
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　Ⅰ　Ⅱa　(Ⅱb)　Ⅲa　Ⅲb　Ⅳ　M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-9 片足立ちは数秒でふらつき、壁に手をついた。 身体機能に大きな問題はなく、起居動作・歩行は自立している。
第2群 生活機能	2-4 食事は自分で摂取しているが、食後すぐに「ご飯はまだか」と尋ねることが週に数回ある(妻より)。 2-10・2-11 着脱は自分で行う。季節に合わない服を選ぶことがあり、妻が衣類を出している。 2-12 妻と週2回、近所のスーパーへ歩いて買物に行く。それ以外はほとんど外出しない。
第3群 認知機能	3-2 妻が予定を伝えても、その日のうちに何度も「今日は何をするのか」と確認する。カレンダーに書いても見ていない。 3-4 調査開始時に見せた3品(ペン・時計・はさみ)を、5分後に1品も答えられなかった。 3-3・3-6・3-7 生年月日、季節、自宅であることは正しく答えた。
第4群 精神・行動障害	4-1 財布や通帳が見つからないと「妻が隠した」と言うことが月に2〜3回ある。見つかると落ち着く。 4-3 自治会の話をしている時に急に涙ぐむことがあった。妻によると、ささいなことで怒ったり泣いたりすることが増えた。 4-5 調査中に、免許を返納した話を3回繰り返した。家でも毎日同じ話をする(妻より)。 4-12 鍋を火にかけたまま忘れたことが今月2回あり、それ以降は台所に立たせていない(妻より)。
第5群 社会生活への適応	5-1 朝・夕の内服(糖尿病薬2種・降圧薬1種)。自分で飲むと言うが、飲み忘れや二重に飲んだことがあり、現在は妻が毎回手渡して服用を確認している。 5-2 小遣い程度の現金は自分で持つが、通帳・カード・公共料金の支払いは妻が管理している。 5-3 普段の着る物や食べる物は自分で決めるが、入院や契約のような大事なことは判断できず、長女に相談している。 5-5 妻と一緒にスーパーに行き、品物は自分で選ぶ。同じ物を何度もかごに入れるため、妻がそばで確認している。 5-6 火の消し忘れがあってから、調理はすべて妻が行っている。
特別な医療	該当なし。

主治医意見書

テスト用架空事例

申請者	木村 正一　(男・78歳)　医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. アルツハイマー型認知症	約1年前
2. 2型糖尿病	約12年前
3. 高血圧症	約10年前

(2)症状としての安定性	安定
(3)経過及び治療内容	1年ほど前から物忘れが目立ち、物忘れ外来でアルツハイマー型認知症と診断(MMSE 21点)。抗認知症薬を内服中。糖尿病はHbA1c 7.2%で内服治療中。服薬の自己管理が難しく、低血糖や高血糖の危険がある。 投薬:抗認知症薬1種、経口血糖降下薬2種、降圧薬1種。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):J1　認知症高齢者の日常生活自立度:Ⅱb
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題あり/日常の意思決定:いくらか困難/意思の伝達:伝えられる
(3)認知症の行動・心理症状	妄想(物盗られ)、感情の不安定さ
(4)その他の精神・神経症状	なし
(5)身体の状態	利き腕:右/身長165cm・体重63kg/麻痺なし/筋力低下なし/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:自立/車いす:用いていない/歩行補助具:なし
(2)栄養・食生活	食事行為:自立/栄養状態:良好/留意点:糖尿病食(1,600kcal)、間食の管理
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	意欲低下、閉じこもり、低血糖・高血糖 → 服薬の確実な管理、日中の活動と交流の機会の確保
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できる
(5)医学的管理の必要性	訪問薬剤管理指導
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	服薬の確実な管理(低血糖症状に注意)。食事:間食・糖分の取りすぎに注意。
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

進行の予防のため、日中の活動と人との交流の機会をもつことが望ましい。介護者(妻)の負担にも配慮が必要。